

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUCILA LOPES DE OLIVEIRA

IDADE: 74 PESO: 64 ALTURA: 1,45 PROFISSÃO: Do lar

SINTOMAS: Cansaço diurno, fraqueza, Refluxo gastro.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Diclofenac Hct / Vitorin / Domalgim / Qipaz / Cimiprida

Vitalapan / Bupropiona

MÉDICO: Dra. Marcia T. Machado

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não pratica

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: — LANCHE: — JANTAR: —

HORA QUE DORME: não tem horário HORA QUE ACORDA: não tem

COCHILO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 4,5 e/h SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS, 1stent, dispendio, diabetes

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☒ S () N SPO2 C/ CPAP: 88% PRESSÃO NO EXAME: 9cmH2O

08/10/24 Avaliação

15/10/24 P=6,4cmH2O IAH=1,0 e/h med. uso: 1h37' Pte. relata forte dor de cabeça ao colocar a máscara, relatou ter uma sensibilidade ao fixador. Relata também crise de tontura ao deitar, vai iniciar tratamento com melatonina e antiácidos. Ajuste fixador para observação, talvez seja necessário a troca da máscara.

Natasha

29/10/24 P=6,4cmH2O IAH=1,5 e/h med. uso: 2h30' freq: 8,3 e/m

Pte. relata acordar pior ao levantar e esquecer de colocar a máscara ao retornar.

Natasha

19/12/24 P= 6,4 cm H₂O
IAH= 1,3 e/h
m de uso: 4h 49'
fuga: 8,2 l/m

Mulher adaptada

Natasha

06/02
25

P= 6,4 cm H₂O
IAH= 1,5 e/h
fuga: 2,9 e/h
m. de uso: 6h 10'

22d uso 20d.
Relata melhora do peso na
cabeça e ~~postura~~ disposição.
Sua.

12/0

P= 6,4 cm H₂O
IAH= 1,4 e/h
M. de uso: 6h 11'
fuga= 4,4 e/h

Sua cláudia

15/05/25

P= 6,4 cm H₂O
IAH= 1,7 e/h
m de uso: 4h 51'
fuga: 33,4 l/m

Relata estar agitada
a noite e dificuldade
de manter sono
Natasha

07/07
25

P= 6,4 cm H₂O
IAH= 1,0 e/h
m de uso: 4h 26'
fuga: 27,9

Natasha

Nome: LUCILA LOPES DE OLIVEIRA

Data de Nascimento: 31-7-1950

IMC: 30,86

Sexo: Feminino

Data do exame: 23-05-2024

Peso: 64 kg

Altura: 1,44 m

Médico: DRA. MARCIA TIGANI MACHADO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 578,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 134,5 e 167,0 minutos. O tempo total de sono foi de 280,0 min, eficiência de 48,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,3%; estágio N2: 64,8%; estágio N3: 9,8%; sono REM: 21,1%. O índice de despertares foi de 13,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 41,1/hora, sendo 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 175 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 82%, permanecendo 7,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 81 bpm e NREM de 62 - 85 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 41,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

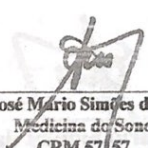
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

Nome: LUCILA LOPES DE OLIVEIRA
Data de Nascimento: 31-7-1950
IMC: 30,86
Sexo: Feminino
Data do exame: 29-07-2024

Peso: 64 kg
Altura: 1,44 m
Médico: DRA. CATHARINA SOARES DE
ANDRADE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 29-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 472,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 24,5 e 180,0 minutos. O tempo total de sono foi de 342,0 min, eficiência de 72,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 60,8%; estágio N3: 13,0%; sono REM: 23,4%. O índice de despertares foi de 12,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,2/hora, sendo 26 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 78 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 88%, permanecendo 0,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 91 bpm e NREM de 63 - 83 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (56,1/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

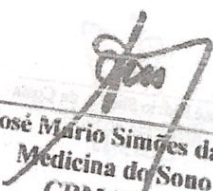
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157